

Communication Inter-Auriculaire (CIA)

Pr RABEARIVONY Nirina
Cardiologue

Introduction

- **Définition:**
 - malformation cardiaque congénitale avec mauvaise fermeture anatomique du septum inter-auriculaire → shunt G-D
- **Epidémiologie:**
 - CIA = 10 % de cardiopathies congénitales

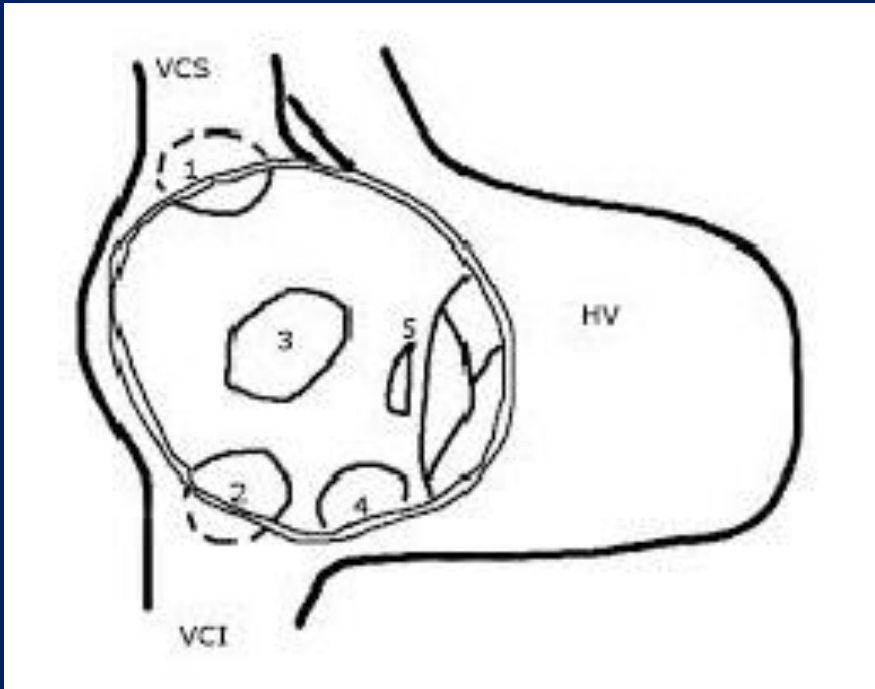
I) Physiopathologie

- **Avant naissance:**
 - **circulation pulmonaire = inexistante**
 - **oxygénation sang fœtal = échange avec sang maternel à travers le placenta, passant / cordon ombilical**
 - **circulation pulmonaire fœtale = déviée vers circulation systémique à travers 2 communications:**
 - ~ **canal artériel (CA)**
 - ~ **foramen ovale (ouverture au niveau SIA)**

I) Physiopathologie

- A la naissance:
 - CA et FO se ferment
 - la persistance d'une communication inter-auriculaire est anormale
 - sang OG (haute P^o) vers OD (basse P^o)
 - shunt G-D

II) Anatomico-pathologie



1 et 2: CIA sinus venosus (10%)

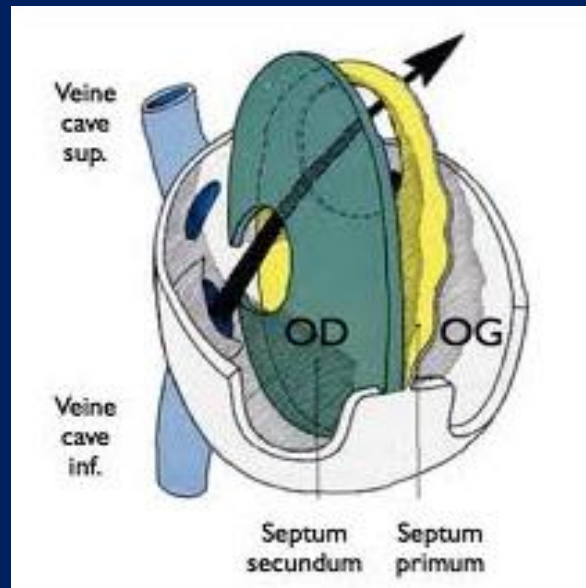
3: CIA ostium secundum (75%)

4: CIA sinus coronaire

5: CIA ostium primum (15%)

II) Anatomico-pathologie

- CIA peut être isolée ou associée à d'autres anomalies (tétralogie de Fallot, transposition corrigée des gros vaisseaux,...)
- Le foramen ovale perméable (FOP) ne fait pas partie des CIA



III) Signes

III.1- Clinique:

III.11- Circonstance de découverte

- CIA = souvent asymptomatique
- → découverte / exam. systématiques

III.12- S. fonctionnels

- dyspnée d'effort
- bronchites à répétition

III.13- Auscultation

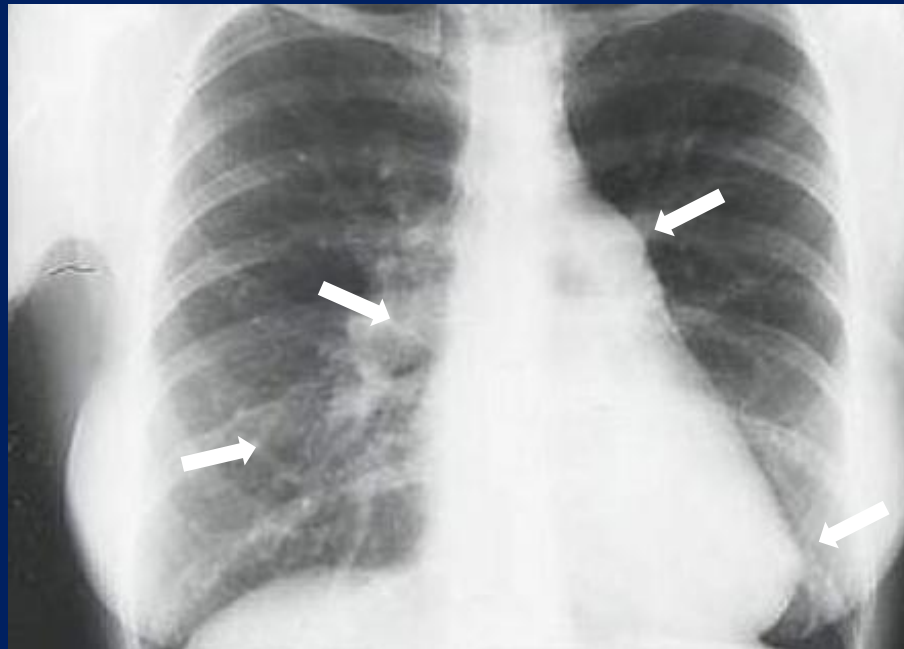
- **S. Systolique au foyer pulm.**
 - **BB2 permanent, espacé**
 - roulement tricuspideen (rare)
- } +++

III) Signes

III.2- Paraliniques:

III.21- Radiographie

- cardiomégalie, pointe surélevée (HVD)
- **AP dilatée** (arc moyen convexe)
- surcharge des hiles pulm.
- hypervascularisation pulm.



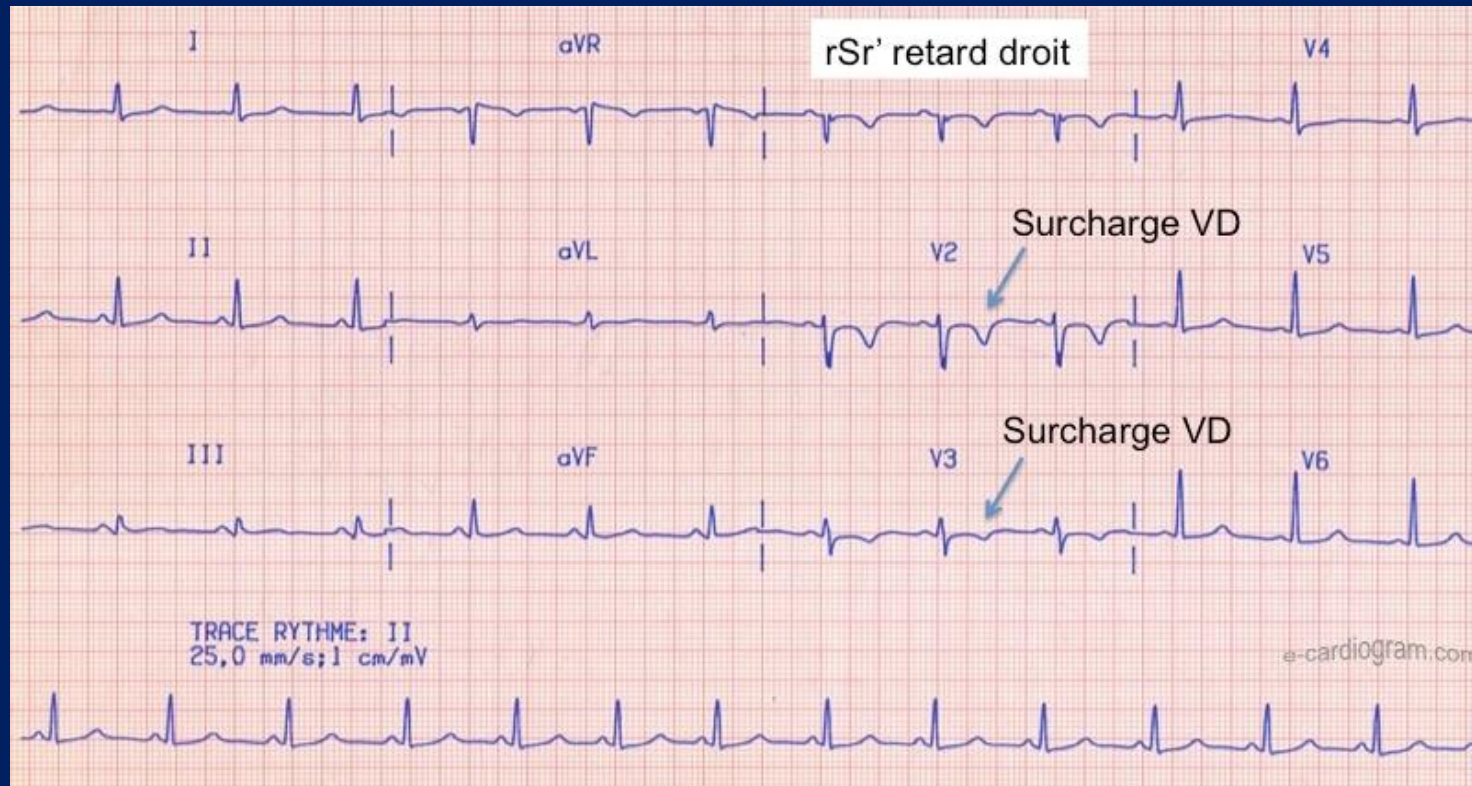
III) Signes

III.2- Paraliniques:

III.22- ECG

- surcharge VD → ~ **Bid**

~ **axe de QRS dévié à Dte**



III) Signes

III.2- Paraliniques:

III.23- Echodoppler cardiaque

- recherche dilatation VD
- localisation et appréciation calibre CIA
- enregistrement du flux à travers la CIA
- calcul du débit du shunt



IV) Diagnostic

IV.1- Positif:

- posé par un faisceau d'arguments:

- SS + BB2 espacé, permanent
- arc moyen convexe
- Bid

- confirmé par l'écho

IV.2- Différentiel:

- FOP

V) Evolution

V.1- Spontanée:

- longtemps bien tolérée
- CIA à petit shunt = espérance de vie normale sans limitation d'activité
- possibilité de fermeture spontanée jusqu'à l'âge de 3 ans:
 - 100 % si < 3 mm
 - 87 % si 3 à 5 mm
 - 80 % si 5 à 8 mm
 - 0 % si > 8 mm

V) Evolution

V.2- Complications:

V.21- Troubles du rythme auriculaire

- en rapport avec une dilatation OD
- Extrasystoles auriculaires
- Fibrillation auriculaire

V.22- Insuffisance cardiaque droite (tardive)

V.23- HTAP

- précoce et sévère (prédisposition génétique)
- tardive et modérée

V.24- Endocardite infectieuse (rare)